

1. Катетеризація сечового міхура катетером Фолея

Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлено пацієнта 78 років з діагнозом: «Гостра затримка сечі».

Скарги: на інтенсивні болі в нижній половині живота, часті болісні безплідні позиви на сечовипускання, почуття переповнення і розпирання сечового міхура, не відходження сечі впродовж 10 годин.

Анамнез захворювання: Впродовж 5-ти років знаходиться під наглядом уролога з приводу аденоми передміхурової залози. Останній рік не лікувався, до лікаря не звертався. Впродовж доби – часті сечовипускання малими порціями сечі з великим зусиллям.

Останні 10 годин – часті болісні безплідні позиви на сечовипускання, почуття переповнення і розпирання сечового міхура, що і стало причиною виклику БШМД.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Аденома простати впродовж 5-ти років. Хворіє ІХС. ГХ. СН, також хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості, положення вимушене, хворий не спокійний, емоційно лабільний. Шкіра бліда, волога. Ріст 184 см, вага 90 кг.

Периферичних набряків немає. Грудна клітка конічної форми, в акті дихання приймає участь симетрично. При аускультатії легень - жорстке дихання; хрипи не вислуховуються.

ЧДР 18 за хв. Межі відносної серцевої тупості розширені вліво. Тони серця приглушені, ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=82 за хв., АТ ліва рука 140/90 мм рт.ст., АТ права рука 140/ 90 мм рт.ст. Живіт не роздутий, приймає участь у акті дихання. При пальпації м'який, різко болісний в надлобковій області, у надлобковій ділянці виступає припухлість у формі кулястого тіла, поверхня його гладка, утворення пружне, перкуторно над ним визначається тупий звук. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальтика є. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення	Референтні значення
Гемоглобін г/л	90	130-160г/л – для чоловіків 120-140г/л - для жінок
Еритроцити $10^{12}/л$	2,6	4,0-5,0 $\times 10^{12}/л$ – для чоловіків

4

3,9-4,7 $\times 10^{12}/л$ – для жінок		
Кольоровий показник	0,79	0,85-1,15
Тромбоцити $10^9/л$	245	180-320 $\times 10^9/л$
Лейкоцити $10^9/л$	14,0	4,0-9,0 $\times 10^9/л$
- лімфоцити%	22	19-37%
- еозинофіли %	1	0,5-5,0%
- палочкоядерні нейтрофіли %	7	0-5,0%
- сегментоядерні нейтрофіли %	73	47,0-72,0%

- моноцити %	7	3,0 – 11,0 %
ШОЕ	10	1 – 10 мм/ч – для чоловіків 2 – 15 мм/ч – для жінок

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення	Референтні значення
Колір - жовта	жовта	Різні відтінки жовтого кольору
Прозорість	каламутна	прозора;
Реакція	кисла	pH менше 7
Питома вага	1,020г / л	1,012 г / л– 1,022 г / л
Лейкоцити	10-12 в полі зору.	0-6 в полі зору для жінок; 0-3 в полі зору для чоловіків;
Епітелій плоский	1-2 в полі зору.	0-10 в полі зору.
Білок	0,33 г.л	відсутній
Еритроцити	20-25 в полі зору,	0-3 в полі зору для жінок; 0-1 в полі зору для чоловіків;
Слиз	відсутня	відсутня
Солі	відсутні	відсутні
Глюкоза	відсутня	відсутня
Циліндри	відсутні	відсутні

УЗД- дослідження передміхурової залози та сечового міхура.



12. Інструкція для стандартизованого пацієнта (за необхідності, якщо це передбачено умовами роботи на станції).

№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Відповідь на питання: Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	інтенсивний біль у животі, неможливість

		сечовипускання.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	Затримка сечі до 16 год, лікується у лікаря уролога з приводу аденоми передміхурової залози
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекціязаперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Під час огляду відзначається занепокоєння пацієнта, відсутність вільного відтоку сечі. Живіт помірно здутий, особливо в нижніх відділах, асиметрії немає. Над лоном може бути візуально помітне випинання — підозра на переповнений сечовий міхур.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	При пальпації нижніх відділів живота виявляється округле, щільно-еластичне болісне утворення над лобком — характерна ознака переповнення сечового міхура. Болісність у надлобковій ділянці, без симптомів подразнення очеревини.
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Перкусія над лобком виявляє зону тупого звуку, що підтверджує наявність рідини в сечовому міхурі. У нормі ця ділянка має бути тимпанічною.
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Аускультация живота не дає додаткових діагностичних ознак у даному випадку. Перистальтика збережена, без патологічних шумів.
4.Діагностика		
4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	ЗАК: легка анемія, лейкоцитоз, зсув вліво. В сечі — лейкоцитурія, мікрогематурія, протеїнурія. Оцінка запального маркеру (лейкоцити, ШЗЕ).
4.2	Проаналізувати оглядову рентгенографію органів грудної клітини	УЗД демонструє розширений сечовий міхур з великою кількістю залишкової сечі, збільшення об'єму передміхурової залози (гіперплазія), відсутність каменів у сечовому міхурі.

4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Аденома передміхурової залози. Гостра затримка сечі.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Невідкладне проведення катетеризації сечового міхура. Надалі — призначення альфа-адреноблокаторів (тамсулозин, доксазозин), можливе додавання інгібіторів 5-альфа-редуктази (фінастерид). Ципрофлоксацин – 500 мг 2 р в д 10 днів. Дотримання питного режиму, уникнення подразнюючих продуктів. При неефективності медикаментозної терапії — Трансуретральна резекція передміхурової залози.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Рекомендовано обмежити вживання алкоголю, кави, гострої їжі, не переохолоджуватись. Регулярні урологічні огляди після 50 років. Контроль об'єму залишкової сечі, підтримка активного способу життя. Пити воду рівномірно протягом доби.
7.Інше		
7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Пацієнта проінформовано про ризики рецидивів гострої затримки сечі, можливі ускладнення: інфекції сечових шляхів, гідронефроз, ниркова недостатність.

Чек-лист до практичної навички «Катетеризація сечового міхура катетером Фолея»

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Встановити контакт з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль), коректне розташування лікар-пацієнт (пацієнт-жінка: лежить на спині, ноги зігнуті в колінах, розвести стегна – позиція Валентайна; пацієнт-чоловік: лежить на спині, розведені стегна)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Підкласти під пацієнта клейонку, між ногами поставити ємність для сечі.	Виконати

4	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
5	Провести візуальне та фізикальне обстеження зовнішніх статевих органів, визначити рівень наповнення сечового міхура.	Сказати/ Виконати
6	Для чоловіків: утримуючи статевий член у вертикальному положенні, зрушити крайню плоть і оголити головку статевого члена, однією рукою зафіксувати її середнім і безіменним пальцями і розсунути зовнішній отвір сечівника; Для жінок: розвести малі статеві губи великим і вказівним пальцями однієї руки.	Виконати
7	Обробити зовнішній отвір уретри марлевою кулькою з розчином нейтрального антисептика (у чоловіків: голівку статевого члена навколо зовнішнього отвору сечівника в напрямку зверху донизу - від сечовипускального каналу до периферії)	Виконати
8	Другою рукою взяти стерильним пінцетом катетер на відстані 5-7 см від його кінця, нанести стерильну змазку на дистальний кінець катетера, ввести кінець катетера в зовнішній отвір сечівника.	Виконати
9	Поступово пересувати катетер глибше по сечівнику (у жінок – на 10 см; у чоловіків - на глибину 15-20 см, заново перехоплюючи катетер пінцетом кожні 3-5 см, при цьому слід рукою поступово опускати статевий член у бік мошонки. з урахуванням анатомічних особливостей) до появи сечі. Ввести в порт балона 10 мл стерильної рідини (фізіологічний розчин). З'єднати катетер з ємністю для збирання сечі. Уточнити у пацієнта його самопочуття	Виконати